

**NOTFALLPLAN & SOP — HÄUSLICHE INTENSIVPFLEGE**

Handlungsleitfaden bei Tracheostoma-, Beatmungs- &amp; Vitalnotfällen im 1:1-Setting (§ 132l SGB V / § 29 SGB

**NOTRUF  
112**

|                                                                          |                                                         |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Klienten-Name:</b> [Name, Vorname]                                    | <b>Geburtsdatum:</b> [TT.MM.JJJJ]                       | <b>Pflegegrad:</b> [1–5]                   |
| <b>Adresse:</b> [Hohenfelsstraße 34, 35232 Dautphetal]                   | <b>Kanülen-Typ:</b> [z.B. Traco 8.0 gefenstert/gecufft] | <b>Beatmung:</b> [Invasiv / NIV / Spontan] |
| <b>Beatmungsgerät:</b> [Typ & Serien-Nr.]                                | <b>Sauerstoff:</b> [Konzentrator / O2-Flasche l/min]    | <b>Cuff-Druck:</b> [22–26 cmH2O]           |
| <b>DNR/DNI-Status:</b> [Gültige Patientenverfügung liegt vor: JA / NEIN] | <b>Angehörige (24/7):</b> [Name, Tel.]                  | <b>Hausarzt:</b> [Dr. Med. / Tel.]         |

**1. PRIMÄRE NOTFALL-EINSCHÄTZUNG NACH DEM ABCDE-SCHEMA**

| Phase                                  | Fokus & Symptome                                                                             | Sofort-Intervention der Pflegekraft / Ersthelfer                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A — Airway<br/>(Atemweg)</b>        | Verlegung der Trachealkanüle, Sekretpfropf, Dislokation, Stomablutung, Zyanose.              | <b>1. Absaugen</b> (endotracheal max. -0.2 bar)<br><b>2. Innenkanüle wechseln/reinigen</b><br><b>3. Bei Blockade: Kanüle sofort wechseln!</b>         |
| <b>B — Breathing<br/>(Beatmung)</b>    | Akute Atemnot, SpO2 < 88%, Beatmungsalarm (High Pressure / Disconnection), Tachypnoe.        | <b>1. Handbeatmung mit Ambu-Beutel + 100% O2</b><br>2. Beatmungsschläuche auf Abknickung/Wasser prüfen<br>3. Auskultation (Spannungspneumothorax?)    |
| <b>C — Circulation<br/>(Kreislauf)</b> | Pulsverlust, Bradykardie (< 40/min), Asystolie, Schock (RR < 90 mmHg), schwere Blutung.      | <b>1. Bei Kreislaufstillstand: Sofort Reanimation (112)</b><br>2. Druckverband bei Blutung<br>3. Flachlagerung / Beinhochlagerung (außer bei Atemnot) |
| <b>D — Disability<br/>(Neurologie)</b> | Bewusstseinsseintrübung, Krampfanfall (Status epilepticus), Pupillendifferenz, Hypoglykämie. | 1. Atemweg sichern / Absaugbereitschaft<br>2. Blutzucker messen (Glukosegabe bei BZ < 70 mg/dl)<br>3. Notfallmedikation nach Arztanordnung            |
| <b>E — Exposure<br/>(Umfeld/Temp.)</b> | Hypothermie (< 35°C), Hyperthermie (> 38.5°C), Dekubitus-/Wundruptur, Katheterdislokation.   | 1. Patienten wärmen / kühlen<br>2. Zu- und Ableitungen (PEG, Katheter, Infusion) sichern<br>3. Vitalzeichen-Monitoring fortsetzen                     |

**RETTUNGSDIENST-NOTRUF 112 — DIE 5 W-FRAGEN (BEI LEBENSGEFAHR SOFORT ALARMIEREN)**

- **Wo** geschah es? (Genaue Adresse & Stockwerk angeben)
- **Was** ist geschehen? (Trachealkanülenverlegung, Beatmungsausfall, Reanimation)
- **Wie viele** Verletzte/Betroffene? (1 Intensivklient)
- **Welche** Erkrankung/Zustand liegt vor? (Invasiv beatmeter Patient, Tracheostoma)
- **Warten** auf Rückfragen der Rettungsleitstelle! (Nicht zuerst auflegen!)

2. ALGORITHMUS 1: TRACHEOSTOMA- & KANÜLEN-NOTFÄLLE (SOP)

| Szenario / Problem                                            | Klinische Symptome                                                                                                                                                                                             | Schritt-für-Schritt Handlungsanweisung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Akute Kanülenverlegung (Sekretpfropf / Borke)              | <ul style="list-style-type: none"><li>Hoher Beatmungsdruck-Alarm (&gt; 30 cmH2O)</li><li>Zyanose, Atemnot, Brutzelgeräusche</li><li>Abfall der Sauerstoffsättigung (SpO2 &lt; 90%)</li></ul>                   | <p><b>Schritt 1:</b> Sofort endotracheal absaugen (max. 10–12 Sek., Druck -0.2 bar).</p> <p><b>Schritt 2:</b> Bei gefensterter Kanüle: Innenkanüle entnehmen &amp; wechseln.</p> <p><b>Schritt 3:</b> 2–3 ml NaCl 0.9% instillieren, erneut absaugen.</p> <p><b>Schritt 4:</b> Handbeatmung mit Ambu-Beutel + O2. Wenn unmöglich → <b>Sofortiger Kanülenwechsel!</b></p>                                                            |
| 2. Akute Kanülendislokation (Kanüle herausgerutscht)          | <ul style="list-style-type: none"><li>Beatmungsalarm 'Disconnection' / Low Pressure</li><li>Kanüle liegt teilweise/vollständig außerhalb des Stomas</li><li>Massive Atemnot, Stimmentwicklung hörbar</li></ul> | <p><b>Schritt 1:</b> Beatmung entkoppeln, Ruhe bewahren.</p> <p><b>Schritt 2:</b> Cuff vollständig entblocken (Spritze).</p> <p><b>Schritt 3:</b> Ersatzkanüle (gleiche Größe) mit Einführhilfe/Mandrin vorsichtig in Stoma einführen, Mandrin ziehen, Cuff blocken.</p> <p><b>Schritt 4:</b> Kanülenhalteband fixieren, Beatmung anschließen.</p> <p><i>Hinweis: Falls Blockade: Eine Nummer kleinere Ersatzkanüle nutzen!</i></p> |
| 3. Verschlussenes Tracheostoma (Ersatzkanüle geht nicht rein) | <ul style="list-style-type: none"><li>Stoma zieht sich rasch zusammen</li><li>Ersatzkanüle lässt sich nicht einführen</li><li>Zyanose, drohender Erstickungstod</li></ul>                                      | <p><b>Schritt 1: Notruf 112 absetzen!</b></p> <p><b>Schritt 2:</b> Stoma-Spreizer oder Notfall-Guedeltubus/Absaugkatheter als Leitschiene ins Stoma einführen.</p> <p><b>Schritt 3:</b> Falls Tracheostoma epithelialisiert: Maskenbeatmung über Mund/Nase (Stoma abdichten!). Falls nicht epithelialisiert: Beatmung über Stoma mit Kleinkind-Maske.</p>                                                                           |
| 4. Stomablutung (Arrosionsblutung)                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Blut schäumt aus Kanüle / Stoma</li><li>Gefahr der Aspiration &amp; Verlegung</li></ul>                                                                                  | <p><b>Schritt 1: Notruf 112!</b> Cuff sofort leicht überblocken (Aspiration verhindern).</p> <p><b>Schritt 2:</b> Kontinuierlich Blut absaugen.</p> <p><b>Schritt 3:</b> Oberkörper hochlagern, Beruhigung des Klienten.</p>                                                                                                                                                                                                        |

3. ALGORITHMUS 2: BEATMUNGSGERÄTE- & TECHNIK-NOTFALL (MPBetreibV)

| Alarmstufe & Signal                                        | Ursache & Diagnose                                                                                                                                                                             | Unverzügliche Sofortmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRIORITÄT ROT</b><br>(Dauer-Farbton / Rotes Blinklicht) | <ul style="list-style-type: none"><li>Geräteausfall / Totalausfall</li><li>Akku leer (&lt; 5 Min. Restzeit)</li><li>Apnoe / Massive Disconnection</li><li>Druckabfall (Low Pressure)</li></ul> | <p><b>1. Patient sofort vom Gerät trennen!</b></p> <p><b>2. Handbeatmung mit Ambu-Beutel + O2-Zufuhr starten!</b></p> <p>3. Zweites Beatmungsgerät (Ersatzgerät) einschalten &amp; anschließen.</p> <p>4. Gerätetechnik &amp; Stromversorgung durch Zweitkraft prüfen.</p> |
| <b>PRIORITÄT GELB</b><br>(Unterbrochener Ton / Gelb)       | <ul style="list-style-type: none"><li>Hoher Druck (High Pressure / Sekret)</li><li>Leckage (Cuff-Druck zu niedrig)</li><li>Stromnetzausfall (Wechsel auf Akku)</li></ul>                       | <p>1. Patient absaugen &amp; Lage der Kanüle prüfen.</p> <p>2. Cuff-Druck mit Cuff-Messer kontrollieren (22–26 cmH2O).</p> <p>3. Netzstecker / Steckdose / Sicherung prüfen.</p>                                                                                           |
| <b>STROMAUSFALL</b><br>(Netzunterbrechung)                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Stromnetz in der Häuslichkeit ausgefallen</li></ul>                                                                                                      | <p>1. Interner/Externer Akku übernimmt automatisch (Restlaufzeit prüfen).</p> <p>2. Bei längerem Stromausfall: Notstromaggregat / O2-Flasche aktivieren &amp; Energieversorger/112 verständigen.</p>                                                                       |

4. ALGORITHMUS 3: KARDIOPULMONALE REANIMATION (ERC LEITLINIEN 2025)

| Schritt 1: PRÜFEN & ALARMIEREN                                                                                                                                                                                                                                                                | Schritt 2: REANIMATION (CPR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schritt 3: ADVANCED ALS / POST-ROSC                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Bewusstlosigkeit?</b> Laute Ansprache &amp; Schütteln.</li><li>• <b>Atemstillstand / Schnappatmung?</b> (Max. 10 Sek. prüfen).</li><li>• <b>NOTRUF 112 ABSETZEN!</b> (Notfall-Button / Lautsprecher).</li><li>• DNR/DNI-Status beachten!</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Cuff blocken &amp; Atemweg sichern!</b></li><li>• <b>Herzdruckmassage:</b> Drucktiefe 5–6 cm, Frequenz 100–120/min.</li><li>• <b>Beatmung:</b> 10 Beatmungen/Min. kontinuierlich über Ambu-Beutel bei gecuffter Kanüle (ohne Pause für HDM).</li><li>• AED / Defibrillator anschließen.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 100% O2 über Ambu-Beutel.</li><li>• Adrenalin 1 mg i.v./i.o. alle 3–5 Min. (nach Arztanordnung/ALS).</li><li>• Reversible Ursachen behandeln (4Hs &amp; HITS): Hypoxie, Hypovolämie, Hyperkaliämie, Hypothermie.</li><li>• Nach ROSC: SpO2 94–98% anstreben.</li></ul> |

5. ANGEHÖRIGEN- & PFLEGEDIENST-NOTFALLKONZEPT (ÜBERBRÜCKUNG)

| Rolle / Akteur                 | Verantwortung im Notfall- & Ausfallmoment                                                                                                                                                  | Erreichbarkeit & Kontaktdaten                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Pflegefachkraft vor Ort        | Leitet Notfallmaßnahmen ein, setzt Notruf 112 ab, verständigt PDL & Angehörige. Bleibt beim Klienten bis Verstärkung eintrifft.                                                            | Dienst-Handy vor Ort                                                 |
| Angehörige (Erst-Puffer)       | Geschult in Notfall-Absaugung & Alarmen. Sichern im extremen Ausfallmoment (z.B. unvorhersehbarer Schichtausfall) die ersten 2–4 Stunden die Erstversorgung ab, bis Ersatzkraft eintrifft. | <b>Tel:</b> [Angehörigen-Tel.]<br><b>Mobil:</b> [24/7 Notfallnummer] |
| AERIS Pflegedienstleitung      | Organisiert sofortige Nachbesetzung (Springer-Pool / Partner-Pflegedienste / Bereitschaft). Übernimmt bei Bedarf interimistisch vor Ort.                                                   | <b>Inhaber René Krieg</b><br><b>Tel:</b> 24/7 Bereitschafts-Handy    |
| Spezialisiertes Weaningzentrum | Ansprechpartner bei komplexen respiratorischen Krisen, Kanülenproblemen oder BGA-Entgleisungen.                                                                                            | <b>UKGM Marburg Beatmungszentrum</b><br><b>Tel:</b> 06421 / 58-0     |
| Medizintechnik-Provider        | 24/7 Notdienst für Beatmungsgeräte, Sauerstoffkonzentratoren & Absauggeräte.                                                                                                               | <b>24h-Hotline:</b> [Provider-Tel.]                                  |

6. AUSRÜSTUNGS-CHECKLISTE: BETTNAHE NOTFALLTASCHE (§ 12 MPBetreibV)

| Kategorie             | Erforderliche Notfall-Ausrüstung (Vollständigkeit täglich prüfen!)                                                                                                                                                                                                                                           | Status                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tracheostoma / Kanüle | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1x Ersatzkanüle Originalgröße &amp; 1x Ersatzkanüle 1 Nummer kleiner (inkl. Mandrin)</li><li>• 1x Stomaspreizer / Tracheostoma-Dilatator &amp; 2x Kanülenhaltebänder &amp; Kompressen</li><li>• Cuffdruckmesser (22–26 cmH2O) &amp; Blockerspritze (10 ml)</li></ul> | <input type="checkbox"/> Vorhanden<br><input type="checkbox"/> Geprüft |
| Absaugung & Beatmung  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Akku-Absauggerät (betriebsbereit) + 1x Ersatz-Absauggerät + Absaugkatheter</li><li>• Handbeatmungsbeutel (Ambu-Beutel) mit O2-Reservoir &amp; passender Maske</li><li>• 1x Ersatz-Beatmungsschlauchsystem &amp; Bakterienfilter (HME / Feuchte Nase)</li></ul>       | <input type="checkbox"/> Vorhanden<br><input type="checkbox"/> Geprüft |
| Notfallmedikamente    | <ul style="list-style-type: none"><li>• NaCl 0.9% Ampullen (zur Instillation / Befeuchtung)</li><li>• Notfallmedikamente laut ärztlichem Notfallplan (Bronchodilatoren, Rectiolen)</li><li>• Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel, Notfalltaschenlampe</li></ul>                                            | <input type="checkbox"/> Vorhanden<br><input type="checkbox"/> Geprüft |

Ort, Datum: Dautphetal, den \_\_\_\_\_

AERIS Pflegedienstleitung / Inhaber:

Unterschrift Pflegefachkraft / Ersthelfer

René Krieg (Pflegefachmann / AKI-Fachkraft)